

CAPÍTULO 10.14

Exantemas – Primera Parte

PERFIL EUNACOM 1.05.1.014  
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

# Exantemas Infecciosos — Parte I

> Regla general: Si es viral → tratamiento **sintomático**. El diagnóstico de todos es **clínico**.

Comparativa

| TABLA 10.14.1: ENFERMEDAD VS AGENTE       |                     |                                  |                               |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENFERMEDAD                                | AGENTE              | EDAD                             | INICIO DEL RASH               | CARACTERÍSTICAS ÚNICAS                                                                                                                         |
| Sarampión                                 | Virus del sarampión | Cualquiera (erradicado en Chile) | Cabeza → caudal               | Fiebre alta + conjuntivitis + tos. Manchas de Koplik (enatema patognomónico, precede al exantema). Exantema <b>rojo intenso/morbiliforme</b> . |
| Rubéola                                   | Virus de la rubéola | Cualquiera (erradicado)          | Cabeza → caudal               | Fiebre <b>baja</b> . Exantema <b>rosado suave</b> . Adenopatías <b>retroauriculares y cervicales posteriores</b> (muy específico). Artralgias. |
| Eritema Infeccioso (5ª Enfermedad)        | Parvovirus B19      | Escolares (4-12 años)            | Mejillas → EEII/tronco        | Eritema malar bilateral = "signo de la cachetada". Luego exantema <b>en encaje/reticular</b> en EEII. Artralgias.                              |
| Exantema Súbito (Roseóla / 6ª Enfermedad) | Herpesvirus HHV-6   | Lactantes (6m-18m)               | Tronco (después de la fiebre) | Fiebre alta (40-41°C) que cede súbitamente → <b>entonces</b> aparece exantema maculopapular raro. Frecuente en convulsiones febriles.          |

Puntos Clave

- **Sarampión y Rubéola:** Notificación inmediata a SEREMI. En Chile requieren **confirmación con IgM**.

- **Eritema Infeccioso:** Riesgo en embarazada → aborto o muerte fetal (no TORCH propiamente).
- **Exantema Súbito:** No confundir el exantema post-fiebre con alergia a antibiótico si se había iniciado ATB previo.
- Infecciones **erradicadas** en Chile (sarampión, rubéola): buscar extranjeros no vacunados o niños < 1 año sin vacunar.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:  
"Lactante de 10 meses presenta fiebre de 40,5°C por 3 días. Al cuarto día la fiebre desaparece y aparece un exantema maculopapular eritematoso en tronco. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:  
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Exantemas - Primera Parte. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Diagnóstico de exantemas: considerar edad, localización y síntomas acompañantes. Los virales se tratan con paracetamol.
- Sarampión: exantema rojo intenso, fiebre alta, precedido por CONJUNTIVITIS o TOS, manchas de Koplick patognomónicas. Notificación inmediata. Complicaciones: neumonía y encefalitis.
- Rubéola: exantema rosado, fiebre baja, ADENOPATÍAS RETROAURICULARES y cervicales posteriores, artralgias. Riesgo principal: TORCH. Notificación inmediata.
- Eritema infeccioso (parvovirus B19): escolares, SIGNO DE LA CACHETADA (eritema malar) + exantema en encaje. Causa más frecuente de artritis viral en Chile. Riesgo de aborto.
- Exantema súbito (HHV-6): lactantes 6-18 meses, FIEBRE MUY ALTA (40-41°C) que cede y luego aparece exantema. Causa de convulsiones febriles. No confundir con alergia a antibióticos.
- Sarampión y rubéola erradicados en Chile: confirmación con IgM y notificación inmediata obligatorias.
- Fiebre alta: sarampión y exantema súbito. Fiebre baja: rubéola y eritema infeccioso.

**EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (EXANTEMAS - PRIMERA PARTE)****PREGUNTA 1**

Lactante de 10 meses presenta fiebre de 40,5°C por 3 días. Al cuarto día la fiebre desaparece y aparece un exantema maculopapular eritematoso en tronco. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Sarampión
- B)** Rubéola
- C)** Exantema súbito (roséola)
- D)** Eritema infeccioso
- E)** Alergia a antibióticos

**PREGUNTA 2**

Niño de 6 años consulta por eritema intenso en ambas mejillas desde hace 2 días, seguido de un exantema reticular en extremidades. No tiene fiebre significativa. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- A)** Virus del sarampión
- B)** Virus rubéola
- C)** Parvovirus B19
- D)** Virus HHV-6
- E)** Streptococcus pyogenes

**PREGUNTA 3**

Adulto joven extranjero no vacunado consulta por exantema rojo intenso generalizado, fiebre de 39,8°C, conjuntivitis bilateral y tos seca. Al examen se observan lesiones blanquecinas en la mucosa de las mejillas. ¿Cuál es la conducta prioritaria?

- A)** Tratamiento con aciclovir endovenoso
- B)** Notificación inmediata a la SEREMI y solicitar IgM para sarampión
- C)** Iniciar antibióticos empíricos por posible sobreinfección bacteriana
- D)** Tratamiento sintomático solamente, sin notificación
- E)** Solicitar hemograma y PCR para confirmar etiología viral

**RESUMEN: EXANTEMAS - PRIMERA PARTE**

Esta clase aborda los exantemas infecciosos, comenzando con generalidades y cubriendo sarampión, rubéola, eritema infeccioso y exantema súbito. Para diagnosticar exantemas hay que considerar la edad, localización del exantema y los síntomas acompañantes. Los exantemas virales se tratan sintomáticamente con paracetamol. El sarampión (erradicado en Chile) produce un exantema rojo intenso morbiliforme, fiebre alta, malestar general y viene precedido por conjuntivitis o tos, con manchas de Koplick patognomónicas. Se notifica inmediatamente. Complicaciones: neumonía y encefalitis. La rubéola produce exantema rosado con fiebre baja, adenopatías retroauriculares y cervicales posteriores, y artralgias. Su riesgo principal es el TORCH en embarazadas. También de notificación inmediata. El eritema infeccioso (quinta enfermedad, parvovirus B19) afecta escolares, inicia con eritema malar (signo de la cachetada) y luego exantema en encaje en extremidades y tronco. Puede producir abortos y artritis viral. El exantema súbito (roséola, sexta enfermedad, virus HHV-6) afecta lactantes de 6-18 meses con fiebre muy alta (40-41°C, causa de convulsiones febriles) que cede y luego aparece el exantema maculopapular. No confundir con alergia a antibióticos.